

NOTULEN

HARI / TANGGAL : Kamis / 02 Juli 2026
 PUKUL : 09.00 – 12.00 WIB
 AGENDA RAPAT : Rapat Akreditasi

PEMIMPIN RAPAT : Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP
 NOTULIS : Mahesa Yudistiranti
 TEMPAT : Hall Sakura Lantai 5

Berikut hasil notulen :

NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1	Hari Pertama	1. Tempat : Gedung D Lantai – 5	IT → jaringan diperbaiki	IT
		2. 4 ruangan	1. Setiap ruang : 3 laptop (1; notulen & cadangan, 2; PJ bab) 2. Pembagian Ruang : 1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Manajemen 3. dr. Aslichah 4. Wawancara Direksi PT – RS, Kabid	IT
		5. Koordinasi Lapangan	1. Pelayanan : Puput 2. Manajemen : drg. Wira	Kabid
		6. Back up File	Masukkan di link google PT	Sekre
2.	Penentuan Tim	1. Notulen 1) Notulen Telusur : a. Manajemen : Kiki, b. PCC : Sherly c.	1. Notulen Online a. Manajemen : Nur Rizkiah Amalia b. PCC : Bernard c. Cadangan / bergantian : Kia	
		2. MC	Hari Pertama – Ketiga	Mayputri
		2. Seragam	1. Hari Kedua : Jas Orange 2. Hari Ketiga : Abu Hijau / Orange	Sekre
		4. Telusur	1. Surveior Manajemen 1) Pendamping :drg. Wira – dr. Resti	1. Kabid 2. Karu



			2) Notulen : Nur Rizkiah Amalia 3) Dokumentasi : 2. Surveior PCC : a. Pendamping : Sherly - Puput b. Notulen : Bernard c. Dokumentasi : 3. Tracker	
		5. Pemimpin Yel	1. Eriko 2. Mada	Karu
		6. Kedatangan	06.30 WIB sudah di Hall	PJ Bab
		7. Opening	1. Pastikan safety briefing dan Indonesia raya aman 2. Buat cadangan jika macet	IT
		8. Code Red dan Code Blue	Gladi Bersih dilihat langsung oleh dr. Aslichah	MFK
3.	Telusur PCC	1. Telusur rekam medis setiap bab	1. Setiap bab menyiapkan rekam medis → masing-masing 5 RM (Bedah, Rujuk, APS, Meninggal, px kompleks 2. Lengkapi RM	1. RM 2. Karu 3. All Bab
		2. Dokumentasi komunikasi antar staf klinis	Antar PA koordinasi menentukan	
		3. Telusur farmasi	1. telaah rekonsiliasi obat 2. pengkajian resep 3. verifikasi 5 benar dan double check 4. PTO dan pemantauan ESO	PKPO
		4. Telusur edukasi	1. identifikasi kebutuhan edukasi 2. Materi edukasi kolaboratif 3. proses pemberian edukasi 4. edukasi rujukan	KE
		5. Ruang yang dikunjungi	R. Inap Bedah	IKO



		6. Edukasi pasien	Seluruh pasien harus edukasi lengkap → edukasi ke pasien untuk membantu menjawab keperluan akreditasi	IRNA
		7. IKO	Ruangan harus bersih	IKO
		8. Pendaftaran	1. Form admisi dilengkapi -> disamakan dengan pengkajian kebutuhan edukasi 2. Semua yang ditanyakan masuk form admisi 3. General concern – aturan pendamping pasien 4. petugas pendaftaran yang ditugaskan saat survei memahami jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut	RM - Pendaftaran
		9. IGD	1. Proses skrining dan triase 2. Pengkajian gawat darurat (dokter dan perawat) 3. Proses stabilisasi pasien sebelum transfer 4. Skrining risiko jatuh dan upaya intervensinya 5. Transfer internal dan eksternal (rujukan) 6. Pasien MAM 7. Floor stock obat di IGD (bukti supervisi oleh Apoteker) 8. Emergency kit 9. Observasi ambulans : ketersediaan emergency kit dan peralatan life support	IGD
		10. PIPP	1. Ditanya alur pengaduan 2. Pembagian 3. Penanganan	PIPP
		11. Radiologi dan Laboratorium	1. Observasi tempat penyimpanan apron dan film 2. Prosedur pelaporan hasil kritis 3. Bukti PMI (Pemantapan Mutu Internal) 4. Bukti PME (Pemantapan Mutu Eksternal) - termasuk kalibrasi alat	1. Radiologi 2. Laboratorium



			5. Mutu unit radiologi (penetapan TAT termasuk mutu kontrak dan mutu terkait evaluasi kinerja Dokter dan staff) 6. Penyusunan risk register unit radiologi dan upaya mitigasinya 7. Pelaporan dan tindak lanjut IKP	
	Telusur Manajemen : Hari Kedua	1. TKRS	MFK, PMKP, PPI, KPS, KE ikut menjawab yang ditanyakan surveyor sesuai bab nya masing-masing	1. MFK 2. PMKP 3. PPI 4. KPS 5. KE
		2. SDM	1. OPPE → Kepala Unit / Kepala Ruang harus mengetahui penilaian DPJP → Penilaian dari Komite Medis 2. Penilaian kinerja harus satu suara dari KPS dan Unit	SDM
		3. IRJA	1. Karu harus bisa mevalidasi data 2. Proteksi kebakaran : Smoke / heat detector, APAR (termasuk simulasi APAR), Jalur evakuasi 3. SPK RKK Dokter perawat	IRJA
3	Telusur Manajemen : Hari Ketiga	1. IGD (termasuk PONEK)	2. PPI : Limbah infeksius, sterilisasi instrumen, pengelolaan linen dan pembersihan permukaan, simulasi hand hygiene 3. Simulasi spill kit 4. SPK RKK tahun 2025 - 2026 di Unit	1. IGD 2. PPI
		2. Prognas	1. TB : observasi poli TB (termasuk pojok sputum dan alur pelayanan pasien TB), observasi screening kasus TB 2. HIV : observasi poli HIV, observasi privasi pasien dan kerahasiaan data pasien HIV 3. Stunting dan wasting : observasi poli anak / KIA, wawancara alur deteksi dan penanganan stunting dan wasting 4. KB : observasi poli Obsgyn / KIA, telusur kelengkapan alat dan obat peraga serta materi edukasi	Prognas



			5. PPRA : wawancara dengan Dokter, apoteker dan perawat terkait evaluasi penatagunaan antimikroba	
		3. Kamar Operasi	1. Observasi jalur masuk pasien dan jalur masuk petugas 2. Kebersihan ruang ganti petugas 3. Fasilitas : gas medis, proteksi kebakaran (smoke / heat detector, APAR (termasuk simulasi APAR), jalur evakuasi) 4. Peralatan medis : inventarisasi alat medis, kalibrasi alat medis, jadwal pemeliharaan rutin alat medis 5. PPI : Limbah infeksius, sterilisasi instrumen, pengelolaan linen dan pembersihan permukaan 6. Penyimpanan instrumen dan linen steril 7. Penyimpanan B3	IKO
		4. Kamar Jenazah	Kamar jenazah jangan dibuat sebagai ruang transit saja → tetap disiapkan petugas dan alatnya	Penunjang
		5. Gizi	Alur yang jelas untuk ruang ganti karyawan	Gizi
		6. Laundry	Tembok yang hitam kotor di cat	Laundry
		7. Mutu	Ambil sampel 2 - 3 unit dan bisa dari unit penunjang medis (contoh : Farmasi, Radiologi) maupun unit non klinis (contoh: IPSRS) Tujuan wawancara di sini adalah untuk menilai apakah Kepala Unit betul - betul memahami dan menjadi penanggungjawab dalam upaya mutu dan manajemen risiko di unit (tidak hanya di "top down" dari komite mutu saja)	Mutu



		8. PPI	1. PPI standby di semua unit → PJ PPI unit yang ditugaskan 2. Harus paham manrisk klinis dan non klinis	PPI
--	--	--------	---	-----

Pemimpin Rapat
Ketua Akreditasi

Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP

Malang, 02 Juli 2026

Notulis

Mahesa Yudistiranti, S. AP

Mengetahui
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

DOKUMENTASI

